

BẢN GIẢI NGHĨA KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM MÁU

Dùng để in và mang theo khi trao đổi với thầy thuốc hoặc bác sĩ

Họ tên	Ngô Quang Cừ	Năm sinh	16/02/1954
Ngày xét nghiệm	01/04/2026	Nguồn đọc	Từ ảnh phiếu xét nghiệm BV Tâm Trí Đà Nẵng

TÓM TẮT NHANH: Có 4 vấn đề chính cần lưu ý: tiểu cầu rất thấp (44), bạch cầu thấp với bạch cầu trung tính thấp (ANC 0.69), thiếu máu hồng cầu to, và chức năng thận giảm nhẹ.

1. NHỮNG CHỈ SỐ CẦN CHÚ Ý

Chỉ số	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Nhận xét ngắn
WBC	2.04 G/L	4 - 10	Thấp
NEU# (bạch cầu trung tính tuyệt đối)	0.69 G/L	1.7 - 7.5	Thấp rõ, dễ tăng nguy cơ nhiễm trùng
RBC	2.85 T/L	4 - 5	Thấp
Hemoglobin	106 g/L	120 - 160	Thiếu máu mức nhẹ - vừa
Hematocrit	31.1 %	35 - 55	Thấp
MCV	109.1 fL	80 - 97	Hồng cầu to
PLT (tiểu cầu)	44 G/L	150 - 450	Rất thấp, tăng nguy cơ chảy máu
Creatinin	112 umol/L	59 - 104	Hơi cao
eGFR	55.97 mL/phút/1.73m ²	> 60	Giảm nhẹ chức năng thận
LDL-C	2.78 mmol/L	Mục tiêu thường < 2.6	Hơi cao so với mục tiêu thông thường
HbA1c	6.18 %	< 6.5	Nằm trong vùng tiền đái tháo đường

2. GIẢI NGHĨA DỄ HIỂU

- Tiểu cầu 44 G/L: đây là mức thấp rõ. Dễ bầm tím, chảy máu chân răng, chảy máu cam, tiểu máu, đi cầu phân đen hoặc chảy máu lâu cầm hơn bình thường.
- Bạch cầu 2.04 G/L và NEU# 0.69 G/L: cơ thể đang thiếu bạch cầu trung tính - là loại giúp chống nhiễm trùng. Nếu có sốt, ho, tiểu buốt, đau họng, vết loét miệng hoặc mệt tăng nhanh thì cần đi khám ngay.
- Hemoglobin 106 g/L, HCT 31.1%, RBC 2.85 T/L: có thiếu máu. Điều này có thể gây mệt, chóng mặt, yếu sức, hụt hơi khi gắng sức.
- MCV 109.1 fL: hồng cầu to. Kiểu này thường gợi ý thiếu vitamin B12, thiếu folate, ảnh hưởng rượu/bia, bệnh gan, tác dụng phụ thuốc, hoặc bệnh lý tủy xương.
- Creatinin 112 và eGFR 55.97: chức năng thận giảm nhẹ. Khi dùng thuốc hoặc thảo dược càng cần cẩn trọng vì thận đào thải thuốc.
- HbA1c 6.18%: chưa tới ngưỡng chẩn đoán đái tháo đường, nhưng đang nằm trong vùng tiền đái tháo đường, nên cần theo dõi ăn uống và đường máu.

3. KẾT LUẬN CHUNG TỪ BỘ XÉT NGHIỆM NÀY

Kết quả này không chỉ là 'tiểu cầu thấp' đơn thuần. Thực tế đang có giảm cùng lúc nhiều dòng tế bào máu: bạch cầu thấp, tiểu cầu thấp và thiếu máu, kèm theo hồng cầu to.

Kiểu hình này thường cần bác sĩ tìm nguyên nhân ở nhóm: thiếu vitamin B12/folate, tác dụng phụ thuốc, rượu, nhiễm siêu vi, bệnh gan/lách, hoặc bệnh lý tủy xương như rối loạn sinh tủy.

Vì vậy, nếu chỉ điều trị theo hướng bổ chung hoặc tự dùng thuốc/thảo dược mà chưa làm rõ nguyên nhân thì có thể bỏ sót bệnh quan trọng.

4. NHỮNG XÉT NGHIỆM NÊN HỎI THÊM BÁC SĨ

- Phết máu ngoại vi và bác sĩ huyết học đọc lam máu
- Vitamin B12, folate, sắt, ferritin, reticulocyte
- Đông máu cơ bản nếu có chảy máu
- Chức năng gan, siêu âm bụng nếu bác sĩ thấy cần
- Tìm nguyên nhân nhiễm trùng/siêu vi theo khám lâm sàng
- Nếu bác sĩ nghi bệnh tủy xương: có thể cần tủy đồ hoặc sinh thiết tủy

5. DẤU HIỆU CẦN ĐI VIỆN NGAY

- Sốt từ 38°C trở lên hoặc rét run
- Chảy máu cam, chảy máu chân răng khó cầm
- Đi cầu phân đen, nôn ra máu, tiểu ra máu
- Bầm tím lan nhanh, nổi nhiều chấm đỏ dưới da
- Đau đầu dữ dội, lơ mơ, yếu tay chân, té đập đầu
- Khó thở tăng, mệt lả, choáng váng nhiều

6. ĐOẠN TÓM TẮT NGẮN ĐỂ GỬI THẦY THUỐC / BÁC SĨ

Bệnh nhân nam 72 tuổi. Xét nghiệm ngày 01/04/2026 cho thấy giảm nhiều dòng tế bào máu: WBC 2.04 G/L, bạch cầu trung tính tuyệt đối 0.69 G/L, Hb 106 g/L, MCV 109.1 fL, PLT 44 G/L. Kèm creatinin 112 umol/L và eGFR 55.97 mL/phút/1.73m². Nhận định: giảm tiểu cầu rõ, giảm bạch cầu trung tính, thiếu máu hồng cầu to, chức năng thận giảm nhẹ. Đề nghị ưu tiên đánh giá huyết học để tìm nguyên nhân trước khi dùng thuốc kéo dài.

Lưu ý: Bản này chỉ có giá trị giải thích dễ hiểu từ ảnh xét nghiệm, không thay thế chẩn đoán trực tiếp của bác sĩ.